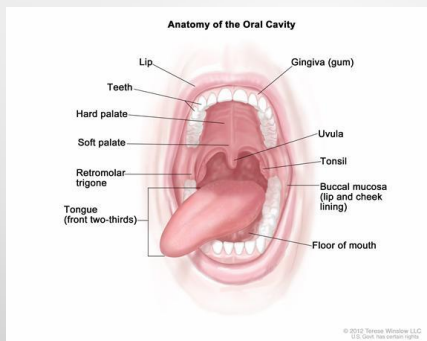
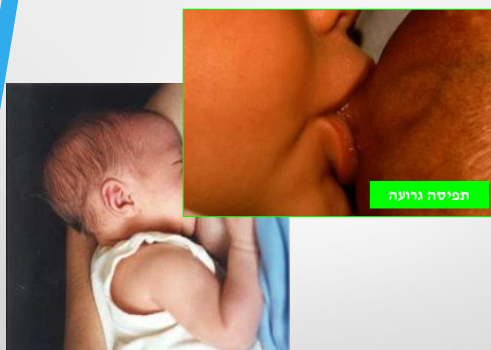


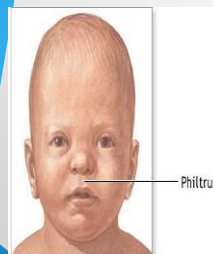


אנטומיה ופיזיולוגיה של חלל פה הילוד



תמיסה גרוועה

שפתיים



- שרירי שפתיים תקינים מאפשרים סגירה טובה שתמנע דליפה של מזון מחוץ לפה.
- נפתחות בזמן החיפוש (rooting)
- הפתיחה הכי אפקטיבית כאשר קיימת נגיעה בפילטרוס.
- מייצבים את השד בפה ומספקים לחץ תור אוראלי.
- חייבים להישאר יציבים במהלך היניקה
- תנועה, מעידה על פיצוי תנועה לא נכונה של הלשון או יניקה שטוחה
- "Fish lips" מעידות על יניקה שטוחה.

חך קשה

- החך הקשה - Hard palate הוא החלק הקדמי של החך.
- החך הקשה מורכב מעצמות המחוברות במפרק פיברוטי (או מפרק צמוד).
- העצמות המרכיבות אותו הן הקיזי הקחי של הלסת העליונה, הנמצאות בקדמת החך הקשה, והחלק האופקי של עצם החך, הנמצאת באחוריו.



לשון

- הלשון היא שריר, הנשלטת על ידי עצם הלשון, תפקידה לתמוך מזון כהכנה לבליעה ליצור כדור (נקרא בולוס) וללעוס
- על הלשון יש עצבים תחושתיים, עצבים מוטוריים, ובלוטות סעם המאפשרים לגוף לדעת מה הוא בולע.
- הלשון מורכבת מתאי אפיתל פשוטים ואפיתל קשקש מרובדת למטרות הגנה וחושיות.
- הלשון היא השריר היחיד בגוף האדם שמחובר רק בקצה אחד שלו.
- מכניסה את השד לתוך הפה מעצבת אותו ומייצבת אותו בחלל הפה



חך

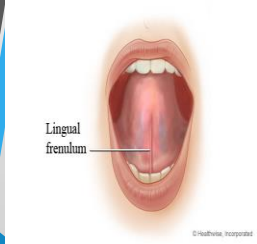
- תפקידו של החך הקשה לסייע בייצוב והחזקת הפטמה בפה
- החך פועל עם הלשון על מנת ליצור אטימה של חלל הפה
- החך עולה בזמן הבליעה נוגע בלוע וחסם את מעברי האף ומסייע בלולס לנוע לעבר בית הבליעה

החך הרך

- החך הרך (Soft palate) הוא רקמה רכה המכסה את אחורי גג חלל הפה.
- הוא נמצא בין החך הקשה לבין הענבל. ובודל מהחך הקשה בכך שבניגוד אליו אין בו עצמות.
- זהו איבר נייד המצויד בסיבי שריר העשויים קרום רירי



פרנאלום frenulum



- הפרנולום היא ממברנה המחזיקה ומעגנת את הלשון לרצפת הפה.
- אם הפרנולום קצר מידי או ממוקם קדימה מידי הוא יכול למנוע תנועה חופשית של הלשון למעלה וקדימה ולפיכך לגרום לבעיות הנקה.



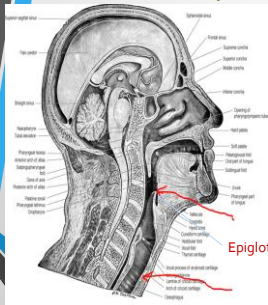
מבנים חריגים של חך



- חך גובה
- חך שטוח
- חך צר
- חך ארוך / קצר
- V חך בצורת
- חך בועתי
- חך מדורג
- חך תעלתי



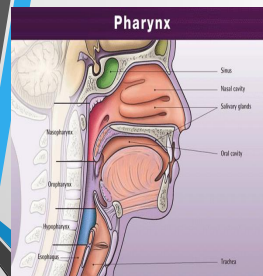
Larynx גרון



- האיבר האחראי למעבר אוויר מן הלוע אל הריאות. הוא נמצא בקדמון הצוואר, מעל קנה הנשימה.
- הוא עשוי תשעה חלקי סחוס ביניהם בלוטות התריס, מחסה הגרון **Epiglottis** אפילגוטיס
- קשור יחד על-ידי רצועות שרירים ומרופדים בקורס יריד ובתוכו נמצא זוג מתני הקול.
- גרון חתינוקות גבוה ותופס יותר מקום משל מבוגר, הוא קצר ובצורת משפך, כשנוזלים עוברים בפה, הגרון מתרוסס כדי שהנוזלים יוכלו לנוע בקלות יותר אל הלוע בזמן הבליעה.



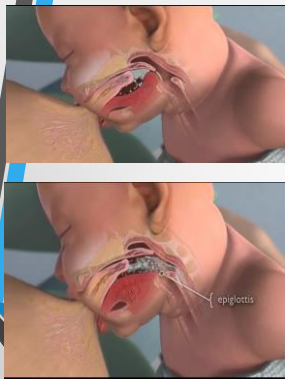
Pharynx לוע



- הוא צינור שרירי, מרופד בקרוס רירי, שנמשך מתחילת הוושש עד לבסיס הגולגולות הוא מחולק לוע הגולגולות nasopharynx לוע עליון oropharynx לוע תחתון hypopharynx

- צורת הלוע משתנה מאוד כשהילד גדל. בלידה הלוע פונה כלפי מטה כדי להתאחד עם חלל הפה.



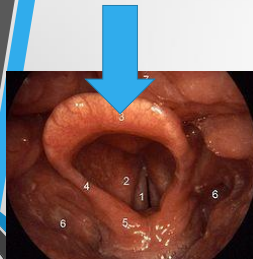


- האפיגלוטיס של התינוקות ממוקם ממש מתחת לחיך הרך (בניגוד למבוגרים) מה שמאפשר למזון לעבור הצידה ולהיכנס ישר לוושט.
- יש לו תפקיד חשוב בחסימת הנתיב לריאות בזמן הבליעה=> חלב עובר לוושט ולא לקנה הנשימה.

מרת אוליבקוביץ

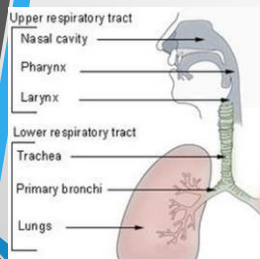
אפיגלוטיס – מכסה הגרון

- **מכסה הגרון או אפיגלוטיס**
הינה רקמת סחוס דקה המכוסה קרום רירי שנמצאת מאחורי שורש הלשון ומחוברת לשאר מבני הגרון באמצעות רצועות שריר.
- מכסה הגרון סוגר את המעבר מקנה הנשימה אל האף בזמן הבליעה ובכך מונע שאיפת מזון.



מרת אוליבקוביץ

Trachea קנה הנשימה



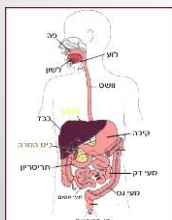
- קנה הנשימה הוא צינור תחילתו בגרון, צולל לאורך הצוואר אל בית החזה, ומתפצל לשני סמפונות שענפיהם מעבירים את האוויר אל הריאות.
- הקנה עשוי מ-15-20 פיסות של סחוס, שעוטפות אותו כמעט לכל אורכו.

מרת אוליבקוביץ



מרת אוליבקוביץ

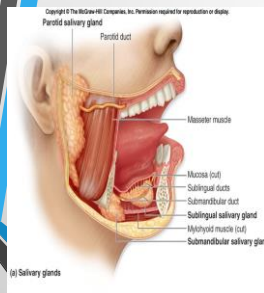
Esophagus – ושט



- הוא צינור שרירי בעל זפנות המצופות בקרום רירי המחבר את החלק התחתון של הגרון
- הושט מרופד בקרום רירי שהפרשותיו מסייעות למזון שנבלע לעבור מן הפה אל הקיבה.



בלוטות הרוק

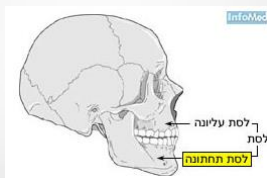


- בלוטות בגוף המייצרות רוק, נחל השומר על לחות הפה וחלקים אחרים של מערכת העיכול.
- הרוק מסייע לפירוק המזון ומחליק, על ידי סיכון, את ירידת המזון מהלוע אל הושט וממנו אל הקיבה.

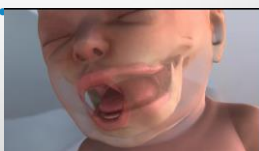
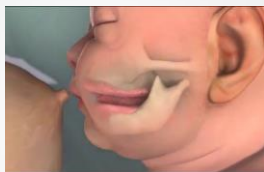


Mandible לסת תחתונה

- עצם דמוית-פרסה, שהמשטח העליון שלה נושא את השניים תחתונות. הענפים האנכיים שלה מופרקים עם עצם הרקה ויוצרים את המפרק הלסת הרקתי.
- בשנה הראשונה הלסת התחתונה גדלה לכיוון מטה- ומגדילה את חלל הפה. הנקה אקטיבית מעודדת את גדילת המנדיבולה (לסת תחתונה) ומחזקת את שרירי הלסת.



- תנועה ריתמית של פתיחה וסגירה מסייעת ללשון לייצר את הלחץ השלילי שיסייע בשחרור החלב
- אצל תינוק לשון והלסת התחתונה פועלים בסנכרון
- אם הלשון לא מתפקדת באופן מלא/טוב הלסת התחתונה והשפתיים ינועו בצורה לא נורמאלית על מנת לסייע לחלב לזרום



השרירים המעורבים ביניקה

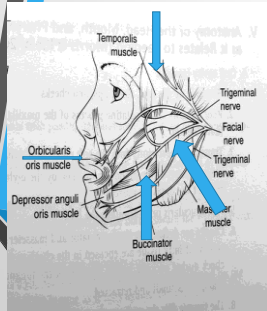
• **Temporalis**: מעלה את הלסת התחתונה סוגר את הפה, מושך את הלסת התחתונה אחורה

• **Masseter**: סוגר את הלסתות

• **Buccinator**: דוחס את הלחי

• **Orbicularis oris**: סוגר את השפיים

• **Mentalis**: מעלה את מרכז השפה העליונה



לחיים

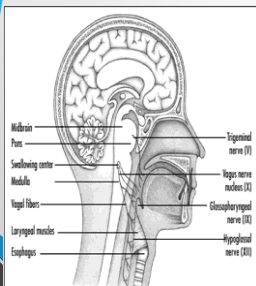
• השומן בחלל הפה (buccal fat) מהוו את הגבול ללשון ומסייע בייצובה

• הם עוזרים להמשכיות חליבה ועוזרים למניעת קריסת הלחיים ושרירי הלחיים אל בין החניכים.

• הלחיים יוצרים לחץ תוך אוראלי בזמן היניקה

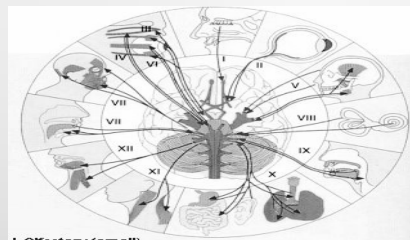


5 העצבים הקרינאליים החשובים לבלעיה



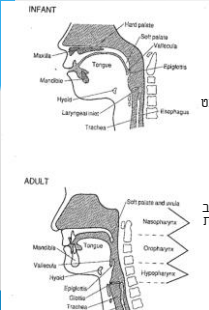
• **trigeminal** **עצב 5 (CN5)** אחראי על תחושה בפנים ולתפקודים מוטוריים מסוימים כמו לנשוך וללעוס.

• **Facial** **עצב 7 (CN7)** עצב הפנים אחראי על שרירי הבעות הפנים, ושולש על פונקציות בשינוע של תחושות מעם משני השלישים הקדמיים של הלשון וחלל הפה.



- I. Olfactory (smell)
- II. Optics (vision)
- III, IV, VI. Oculomotor, Trochlear, Abducens (eye movement)
- V. Trigeminal (touch, pain)
- VII. Facial (face muscles, taste)
- VIII. Auditory (hearing)
- IX. Glossopharyngeal (muscles of throat and larynx)
- X. Vagus (internal organs)
- XI. Spinal Accessory (neck muscles)
- XII. Hypoglossal (tongue movements, taste)

שוני בין מבוגר לילד



- פה התינוק קטן באופן משמעותי ביחס למבוגר
- שכשפה סגור הלשון נוגעת בחניכים ובגג פה.
- לסת התינוק (תמנדיבולה- התחתונה) קטנה יותר ומעט נסוגה אחורה.
- חיד התינוק קצר, רחב וקשתי במעט עם הלידה.
- לחיים עוזרים לתינוק להחזיק את השד בפנים במשך ההנקה, בגלל שלשון התינוק ממלאה את חלל הפה כיוון תנועת הלשון מוגבלת.
- ניצני בלוטות המעט נמצאות בלשון כבר מלידה (לרוב בקצה הלשון), אבל לתינוק יש תגובה מציצה מוגברת רק לסעם מתוק.
- שפתי התינוק מותאמות היטב ויוצרות סגר אוויר מסביב לשד, הן מעט מופשלות החוצה כך שהריר שנמצא בחלל הפה יוכל לצאת.



- **Glossopharyngea** העצב ה-9
עצב הלשון והלוע מעצבב את השקדים הלוע ואת 1/3 האחורי של הלשון (סעם)
- **העצב התועה VAGUS** העצב ה-10
תפקידו לעצבב את הקרביים מפעיל את המערכת העיכול הפרסטלית ולא מעט תנועות שרירים בפה.
כולל דיבור ושמימה על הגרון פתוח לנשימה
- **hypoglossal** עצב 12. עצב הגולגולת.
מוביל לשרירים של הלשון הוא שולט בתנועות לשון של דיבור, מניפולציות מזון ובלעיה.



ROOTING רפלקס



- כשנוגעים בשפתי התינוק או בלחיו בצד אחד הראש יסתובב לאותו כיוון בניסיון לתפוס את פסמת השד.
- מופיע הגיל 32 שבועות
- יכול להעלם מגיל 3-6 חודשים
- העדר או רגישות יתר יכול לפגוע בהנקה

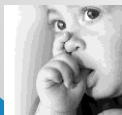


רפלקסים

- מתבטאים בתגובות אוטומטיות לגירויים חיצוניים שונים.
- לרפלקסים אלה יש ערך הישרדותי עבור התינוק. חלקם, מלווים את התינוק גם בהמשך חייו. אחרים נעלמים לגמרי או הופכים לתגובות גופניות רצוניות ומשוכללות יותר.
- יש 2 קטגוריות של ORAL REFLEX
- Adaptive (הסתגלות. התאמה) protective (הגנתי)



רפלקס המציצה sucking



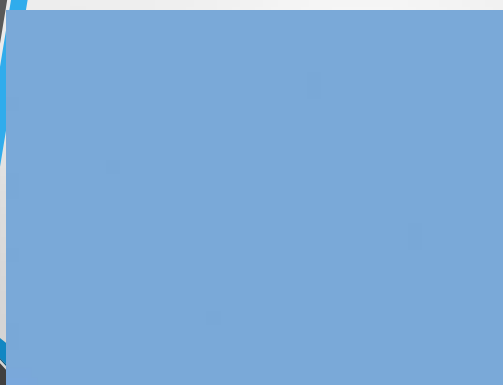
- גורם לחינוק למצוץ במרח דבר שנוגע בפיו (כמו פטמה, מוצץ או אצבע). ביחד עם רפלקס החיפוש מאפשר לחינוק לינוק מיד עם היוולדו.
- מופק על ידי גירוי או לחץ בלשון ובחיבור בן החיך הקשה והרך
- נעלם בן 15-18 שבועות
- פגים : 32 שבועות של יניקות אך ללא קורדינציה
- 34-35 שבועות מסוגלים לינוק לפרקי זמן קצרים



Swallowing רפלקס הבליעה

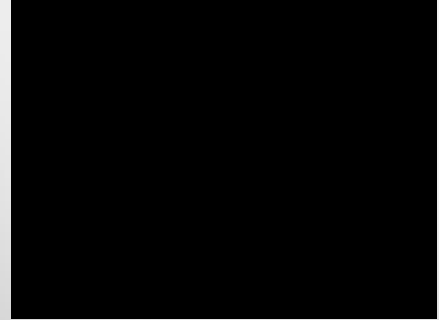
- מופק על ידי מגע הבולוס עם הרצפטורים הסנסוריים של החלק האחורי של הפה.

- שבוע 14-12 ויסות כמות מי השפיר בהריון
- לקראת הלידה העובר בולע כחצי מכמות מי השפיר מידי יום
- בגיל חודשיים פעולת האכילה הופכת רצונית, המציצה והבליעה אמורות להפוך לתנועות רצוניות



Gug reflex

- **רפלקס הקאה** הוא רפלקס התכווצות של החלק האחורי של הגרון, מעורר על ידי נגיעה בגג הפה בחלק האחורי של הלשון, באזור סביב השקדים ובחלק האחורי של הגרון
- מופיע בשבוע ה-18 להריון
- נדחק לקראת גיל 4 חודשים



Protrusion reflex

- תינוקות נולדים עם רפלקס דחיקת לשון, שמגן עליהם מבליעת חפצים וחק. מוכנות לאכילה תתבטא בין השאר בהיעלמותו של רפלקס זה.
- נעלם בגיל 4-5 חודשים.



רפלקס הנשיכה

- גורם לתינוק לנשוך באופן אוטומטי אצבע המוכנסת לפיו. בגיל חודשיים פעולת האכילה הופכת רצונית, המציצה והבליעה אמורות להפוך לתנועות רצוניות.
- מופיע בשבוע 28 להריון נעלם לקראת גיל 9-12 חודשים



שלב הפיכת המזון לבולוס- השלב האורלי פומי

- שלב זה מתחיל עם הכנסת המזון לפה .
- הלשון מעבירה את נוזל/מזון אל החלק האחורי של הפה והופכת אותו לכדורון (bolus)
- בהמשך היא לוחצת את כדורון אל החיך הגרמי ומעבירה אותו לאזור השקדים
- שם מופקת הבליעה.
- חלק זה נחשב לשלב רצוני הנמשך כ 8-10 שניות
- הנשימה נמשכת – מערכת הנשימה פתוחה.



מהי בליעה ?



- בליעה היא תהליך העברת מזון או נוזלים מהפה דרך הלוע והושט ועד הקיבה . זהו תהליך מורכב ומעורבים בו עצבים , שרירים , רפלקסים, בלוטות רוק ובלוטות טעם .



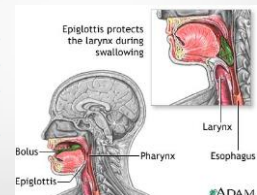
שלב הוושטי

- מהרגע שמופק רפלקס הבליעה ועד הכניסה לוושט – שניה אחת או פחות.
- המעבר בוושט נמשך בין 8 ל-20 שניות.
- שלב בלתי רצוני לחלוטין



שלב פרינגאלי-לועי

- הבולוס עובר ללוע דרך שער הלוע
- שלב חצי רצוני העורך כשנייה
- החיך הרך עולה לאחור וסוגר את המעבר לאף.
- מתחילות תנועות טמיסה בלוע הדוחפות את הכדורון כלפי מטה.



- אנחנו בולעים בממוצע 600 פעם ביום.
- בכל בליעה 1-2 סמ"ק רוק.
- הבליעה היא אירוע המתרחש תוך הפעלת לחץ ועצירת נשימה למשך $1/3-2/3$ שניה.
- מיד עם סיום הבליעה אנחנו פולטים מעט אויר (בלתי נשלט) כהמשך למנגנון ההגנה.



Swallowing

The 3 stages of swallowing:



1. Buccal phase (voluntary)



2. Pharyngeal stage (involuntary)



3. Esophageal stage (involuntary)



תנאים בסיסיים לאכילה מוצלחת:

- מערכת נשימה יציבה.
- יניקה חזקה וקצבית.
- תאום מלא בין מציצה-בליעה-נשימה



בליעה - תינוקות

- בליעה נצפתה בגיל 10-11 שבועות לחיי העובר.
- מציצה מסוג SUCKLING בין 18-24 שבועות.
- אצל פגים בגיל 27-28 שבועות תנועות בודדות.
- בין שבוע 30-33 יותר ארגון. התפרצויות של מציצה והפסקה ביניהן.



מכניזם של היניקה

- התהליך בו מתאורות הסרת החלב מהשד והעברת החלב לתינוק
- לחץ שלילי בחלל הפה VACUUM
- לחץ חיובי – לשון כלפי הפטמה כלפיי החך
- תנועה מעגלית של הלשון כלפי הפטמה ??
- לחץ מוגבר בצינורות

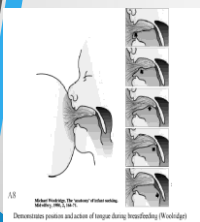


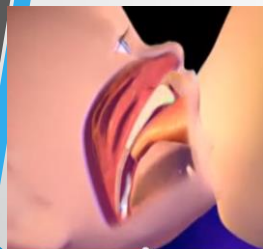
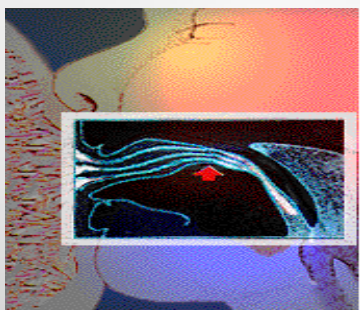
Science of suckling/sucking

- משימה רב מימדית של תאום מושלם ודינמי בן מציצה, בליעה, ונשימה
- מונחים המסבירים תנועת הפה כאשר לא תמיד יש הבחנה ברורה בין השניים



- הפטמה וחלק מהחלק התחתון של העטרה נמשכים עמוק פנימה לתוך פה התינוק, אז שפתיו ולחיו של התינוק אוטומות סביב. שפתי התינוק מופשלות החוצה ותפקידם ביניקה מינימאלי.
- קצה לשון התינוק נשארת מאחורי השפה התחתונה ומעל החניכים בעוד ששאר הלשון חופנת את שאר העטרה של השד.





- במהלך היניקה הפטמה האלסטית של האימא מתארכת פי 2-3 בעקבות המציצה והלחץ שנוצר בפה התינוק.
- הפטמה מתארכת ומגיעה לחלק האחורי עד לצומת בין החיך הקשה לרך.
- בשלב זה הפטמה מוחזקת בין החיך העליון והלשון שמכסה את החיך התחתון.
- הלסת מזיזה את הלשון למעלה ולוחצת את העטרה כנגד ה-alveolar ridge של התינוק.



השינוי המשמעותי
הוא מצב בו לא
קיימים כבר
lactiferous duct

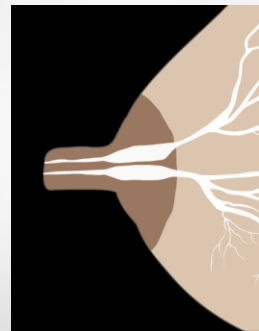
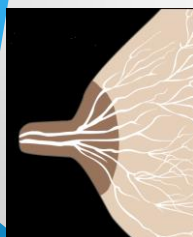
מחקרים חדשים מראים שינויים במבנה האנטומי של
השד



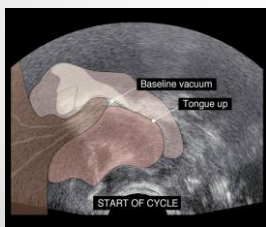
באמצעות שימוש באולטרסאונד



להימצאותם של הסינוסים
הללו היה מקום חשוב
ומרכזי בהבנה כיצד התינוק
יונק



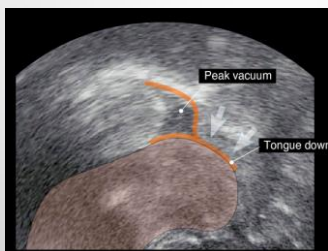
נמצא שכאשר מתקיימת יניקה החלק
האחורי של הלשון נדחס כלפי מעלה



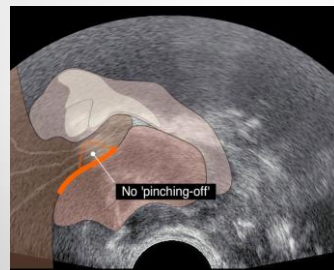
האולטרסאונד מוקם במרכז הפנים של
התינוק



נוצר וואקום כאשר הלשון יורדת בחלקה האחורי
כלפי מטה ונותר חלל האפשר שחרור חלב



הלשון לא לוחצת את צינורות החלב בתנועה
מעגלית



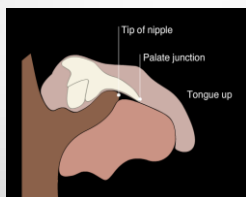
כאשר החלב משתחרר הלשון עולה מעט
החלב יוכל לזרום לעבר החך הרך



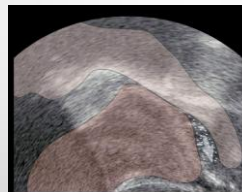
ניתן לראות שצינורית החלב מתרחבות ומאפשרות
זרימה של החלב לחלל



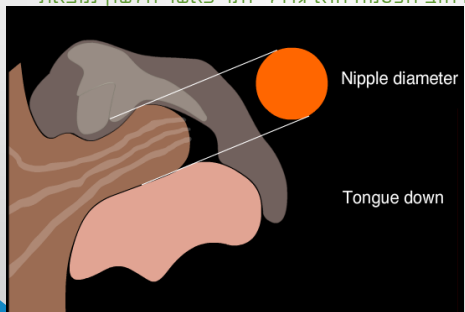
קצה הפטמה לא נוגע במעבר בין החיך
הרך לחיך הקשה



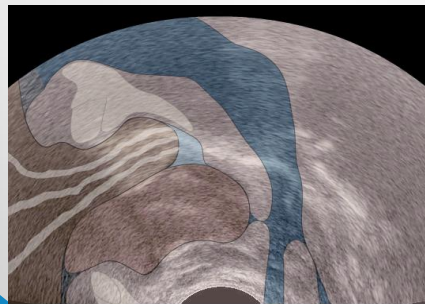
הלשון עולה שוב לעבר החך
הרך
והחלב זורם לעבר הלוע



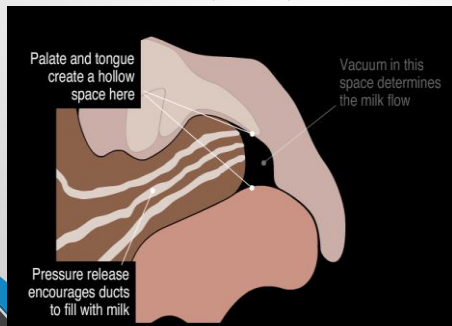
רוחב הפטמה הוא גדול יותר כאשר הלשון נמצאת



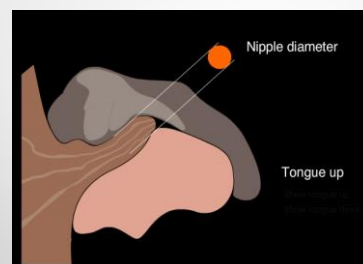
אין הוכחה שהלשון זזה בתנועה מעגלית



ככול שיש יותר מרחק בן הלשון לחיך ייווצר
ואקוום חזק יותר

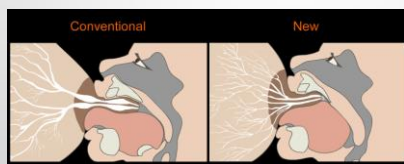


כאשר הלשון למעלה הפטמה הכי "מחוצה"

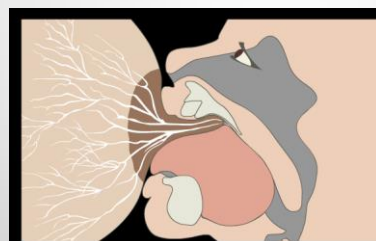


כאשר משווים את ההבנה החדשה אם מה שידוע בעבר

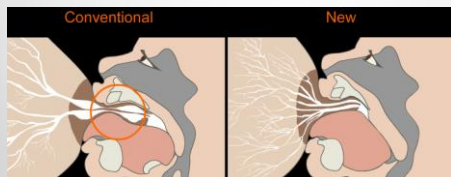
לדקוים יש תפקיד מרכזי בהעברת החלב



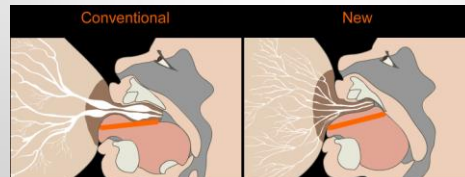
מסקנה - וואקום פנים אוראלי ולא תנועה מעגלית
של הלשון הם שיוצרים את הזרמת החלב מהשד
לפה התינוק



המחסור בתנועה מעגלית מראה
שהפטמה נשארת כל הזמן באותה
צורה

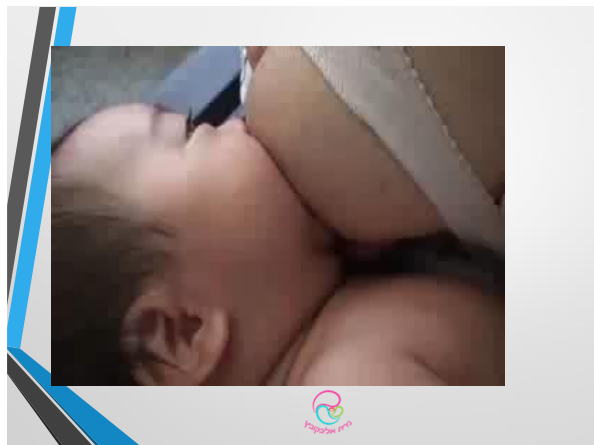


הלשון לא זזה בתנועה מעגלית החלב
לא נסחט מהצינורות



יניקה תזונתית-Nutritive

- זרימת חלב מלאה ומתמשכת
- הנקה לצורכי תזונה

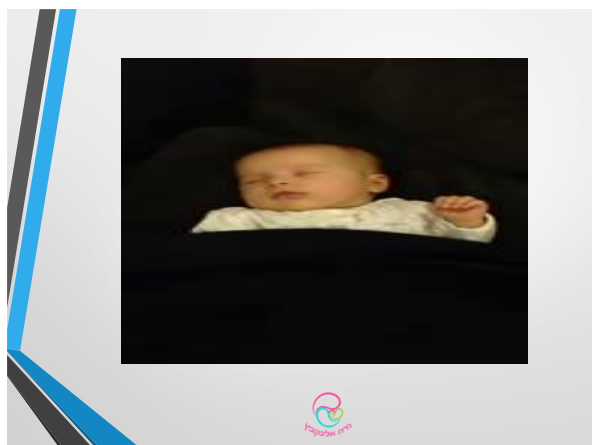


Non nutritive יניקה לא תזונתית

- בהעדר זרימת חלב
- מספקת יצר בסיסי למציצה או כאמצעי הרגעה
- קצב היניקה משתנה בהתאם למידת זרימת החלב
- מגביר פריסטלטיקה
- מגביר את הפרשת מיצי העיכול
- ומוריד בכי.
- האיפיון: דפוס של פרצי יניקה והפוגות

נשימה ויניקה Breathing and Suckling

- במחזור נורמאלי מתואם של יניקות תזונתיות, הבליעות לא מפריעות לנשימה.
- הנשימה ממשיכה עם מחזור המציצות.
- בתחילת הבליעה, כשהחלב נכנס ללוע, זרימת אויר עלולה להיפסק לשבריר שנייה ולהתחדש מיד.
- במחזור מושלם של חליבה- בליעה- נשימה תנועת הנשימה קשורה לרצף של 1:1:1



יניקה שטחית מורידה את היציבות בחלל הפה

- יוצרת גומות במהלך היניקה
- פתיחה מוגזמת של השפה העליונה
- היווצרותם של קמטים בצידי הפה
- הימצאותה של בועית הנקה

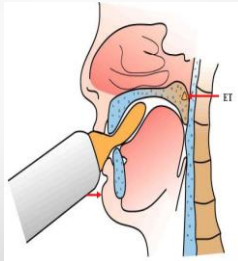


- עם המשך ההנקה מקבצי היניקה נהפכים קצרים עם יותר עצירות תכופות.
- כשזרימת החלב יורדת או נעצרת התינוק יגביר את קצב המשיכה ל- 2 חליבות בשנייה, וכשזרימת החלב תעלה קצב המשיכה יורד.



אכילה מבקבוק

- בתחילת האכלה מעט לחץ חיובי. אם הפסמה רכה, ישתחרר חלב אבל עם פסמה נוקשה הלחץ יגרום לחלב לסגת אל חלל הבקבוק ולכן יהיה צורך בלחץ שלילי מוגבר שפרוש: כיווץ חזק של השפתיים. פעולת הלשון כפעולת בוכנה – תנועות חזקות קדימה אחורה
- התוצאה – דחיקת לשון, הלחיים נשאבות פנימה ומפעילות לחץ על החניכיים מהחוזק פנימה.



תופעות המחשירות קיום קשיי בליעה – דספגיה – בזמן הארוחה

- אי שקט
- מבט מקובע
- עיניים מחפשות
- הבעה מודאגת (כיווץ מצח)
- ישנוניות בזמן הארוחה
- התעייפות מהירה
- התחלה פתאומית של קשיי אכילה





יניקה

- פתיחת פה גדולה יותר כדי לתפוס את הפטמה
- שפתיים משורבבות החוצה רגועות ונחות מסביב לשד ואוסמות אותו
- פעילות מורחבת של הלסת בתחתונה-מנדיבולה

בקבוק

- פתיחת פה קטנה יותר ע"מ לתפוס את פטמת הגומי
- שפתיים סגורות ביחד ולוחצות ע"מ ליצור מגע עם הפטמות גומי
- פעילות מינימאלית של הלסת התחתונה-מנדיבולה



- במידה שזרם החלב חזק, התינוק נאלץ להרים את גב הלשון ולחסום אותו.
- בזמן מנוחה הלשון ממשיכה ללחוץ על הפטמה כדי למנוע זרימת חלב ולשמור על מיקומה בחלל הפה.
- נוצרת גבשושית לאורך כל הלשון.
- תנוחה זו יחד עם הרמת גב הלשון בזמן היניקה, יחד עם הלחץ שיוצרת פטמת הבקבוק, יכולים להשפיע עם הזמן על מבנה החיך



יניקה

- יניקות יותר תכופות פר דקה לא תזונתית: 1 חליבה/שנייה תזונתית: 2 חליבות/שנייה
- דפוס נשימה: קיצור הנשיפה הארכת הנשיפה וקיצור הנשיפה
- משך האכלה משתנה, בין זמן קצר של כמה דקות לארוך +30 דקות

בקבוק

- יניקות פחות תכופות
- דפוס נשימה: הארכת הנשיפה וקיצור הנשיפה
- משך האכלה בד"כ נמשך בין 5-10 דקות.



יניקה

- הלשון אוזחת מסביב לפטמה, נשארת מתחתיה לאורך כל ההנקה. נעה בתנועה גלית פריסטלית מקדמת הפה אחורה
- שקט, למעט קול הבליעות הרך, ובתינוקות גדולים יותר cooing ו singing

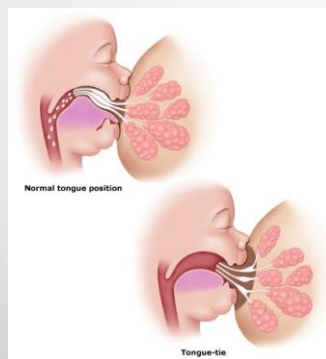
בקבוק

- הלשון מורמת ונלחצת קדימה כנגד קצה פיסמת הגומי "piston-like" כדי לשלוש בזרימת החלב
- רעש חריקה גבוה בסוף כל הכנסה של אויר לפני מציצה חדשה



למה לתינוקות יש בעיות יניקה

- Poor latch
- בעיות אנטומית אוראליות
- חיך שסוע
- לשון קשורה
- לשון גדולה macroglossia
- Micrognathia (לסת תחתונה קטנה או אחורית)
- בעיות נירולוגית – מתח שרירים נמוך



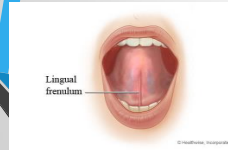
תנועת הלשון במהלך ביניקה

- התארכות extension
לפיתה ומשיכה של השד במהלך החיפוש האורלי
- תצורה configuration
יוצרת מבנה תעלה על מנת לייצב את השד



מהי לשון קשורה ?

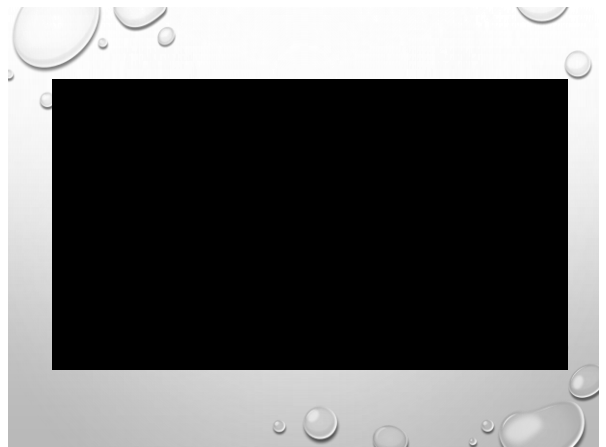
- לשון קשורה או כפי שהיא נקראת באנגלית Tongue-tie הינה בעיה מולדת בה הרקמה המקשרת בין הלשון לבין רצפת הפה מגבילה את התנועה התקינה של הלשון.
- כתוצאה מכך מתקצר טווח התנועה של הלשון, ומיומנויות כמו יניקה, עלולות להיפגע.

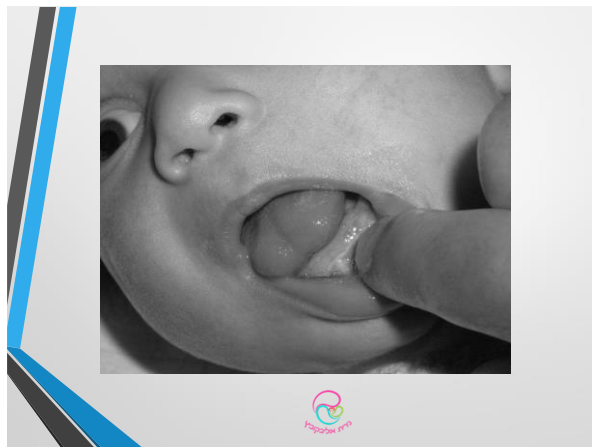
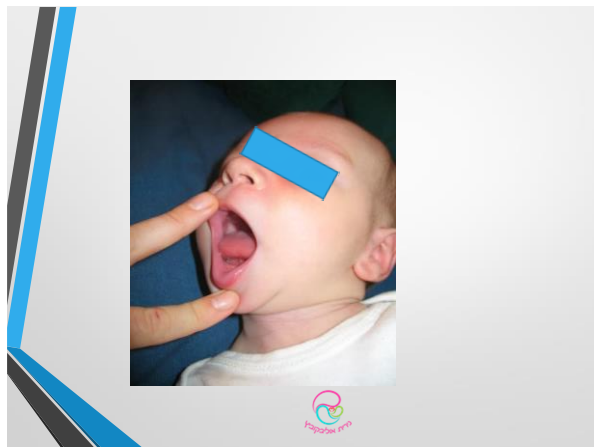


חוסר יכולת להוציא את הלשון Restricted extension



הוצאת הלשון מחוץ לקו החניכים הכרחית בזמן היניקה זאת על מנת למנוע מצב של הפעלת רפלקס הנשיכה

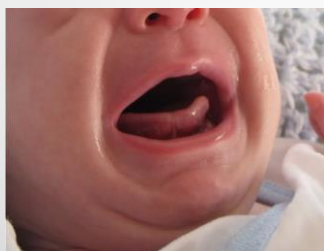




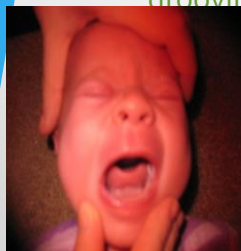
Restricted elevation



היכולת להניע את הלשון כלפי מעלה – היכולת הזו נבחנת כאשר התינוק בוכה הוא אמור להרים את הלשון ולנגוע בחיך כאשר הפה חצי פתוח



grooving /Cupping



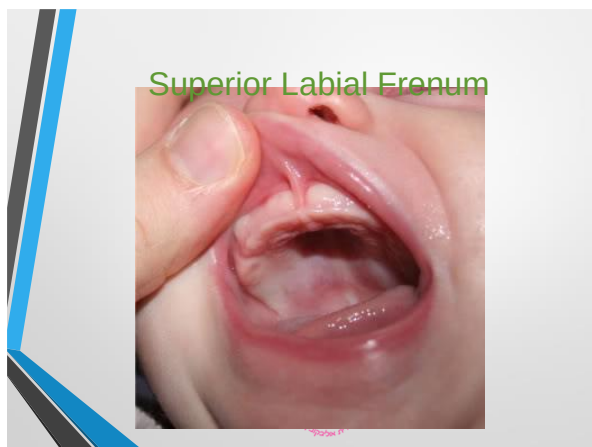
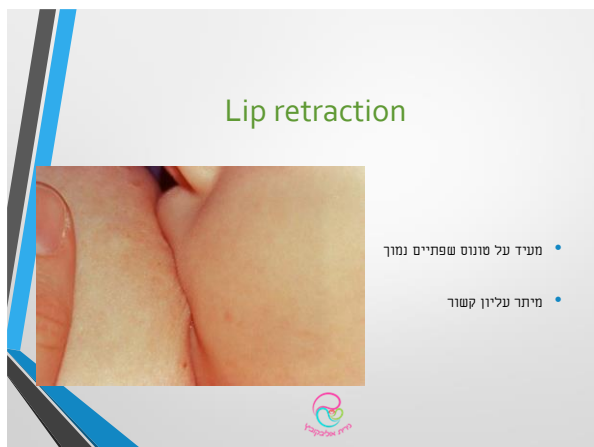
- צידי הלשון אמורים לעלות בצורת תעלה ובכך להקיף את הפטמה לייצבה בפה ולסייע לבלעיה
- אצל ילדים עם לשון קשורה יש מצבים שהמיתר מטפיק אלסטי המאפשר את ה grooving



Lateralization



- היכולת להניע את הלשון מצד לצד
- יותר חשוב באכילת מזון מוצק מאפשר מעבר מזון למרכז הלשון ומנקה את חלל הפה



הערכת תנועתיות הלשון



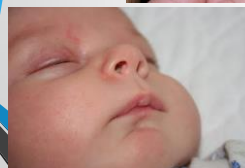
הדרך הטובה ביותר להערכת התנועתיות היא באמצעות מציצה על האצבע כאשר יש נוזל יש תינוקת שיונקים באופן טוב ואפקטיבי



Craved tip syringes •



בחינת בורה



- חולשה בשפתיים
- יניקה לא אפקטיבית
- Lip retraction
- לשון קשורה
- Overuse of lips



- לגרות את השפתיים על מנת לעודד פתיחה
- החלקי את האצבע לתוך הפה לאורך החך
- אפשרי לתינוק למצוץ מס שניות
- משכי את האצבע כאשר יש עדין וואקום
- הוריד את הלשון כלפי מטה

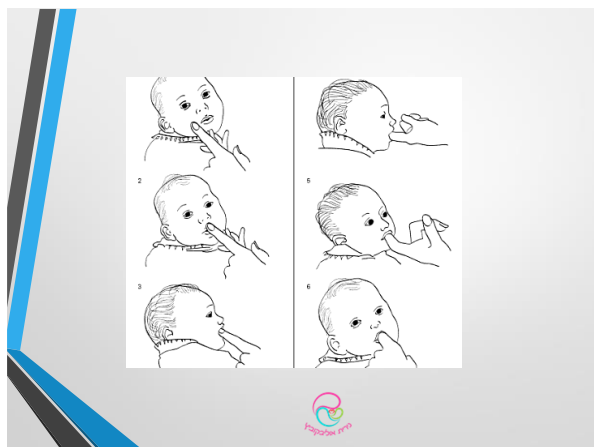


עיסוי הלשון



- תינוקות עם לשון קשורה מתקשים לפעמים להוריד את הלשון כלפי מטה
- גירוי קצה הלשון עם האצבע יכול לסייע להם להוריד את הלשון
- כדאי לעשות זאת תוך כדאי הנקה





עידוד הוצאת הלשון



- לגרות את השפה התחתונה
- להעביר את האצבע מצד לצד על החך התחתון

©2004 Catherine W Genta
Digital assessment of posterior tether, colic and latch difficulties responded to frenotomy.



 נירית אוליבקוביץ